

ΝΟΣΟΣ KAWASAKI

Γενικά: Η νόσος Kawasaki (NK) είναι μια αγνώστου αιτιολογίας, οξεία αυτοπεριοριζόμενη συστηματική νεκρωτική αγγειίτιδα, των μέσου και μικρού μεγέθους αρτηριών, η οποία εμφανίζεται κυρίως σε μικρά παιδιά. Περίπου το 85% των παιδιών με NK είναι κάτω των 5 ετών, με συχνότερη εμφάνιση στην ηλικία των 9-24 μηνών. Παιδιά κάτω των 6 μηνών ή άνω των 5 ετών προσβάλλονται σπάνια, διατρέχουν όμως μεγαλύτερο κίνδυνο δημιουργίας ανευρυσμάτων των στεφανιαίων αγγείων. Η συχνότητα προσβολής των στεφανιαίων αγγείων ανέρχεται στο 30% σε μη θεραπευθείσες περιπτώσεις NK, ενώ περιορίζεται στο 5-10% των παιδιών που υποβάλλονται εγκαίρως σε θεραπευτική αγωγή με ανοσοσφαιρίνη (γ-σφαιρίνη). Η NK είναι πιο συνηθισμένη στα αγόρια από ότι στα κορίτσια, με αναλογία Α/Κ: 1,5/1.

Επιδημιολογικά, παρόλο που κλινικές περιπτώσεις της NK μπορούν να διαγνωσθούν σε οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου, εντούτοις μπορεί να εμφανιστεί κατά εποχές αυξημένος αριθμός περιπτώσεων, όπως στο τέλος του χειμώνα και στην αρχή της άνοιξη. Η ετήσια επίπτωση της NK στην Ευρώπη κυμαίνεται περί τις 5-12 περιπτώσεις ανά 100.000 παιδιά. Η νόσος αποτελεί σήμερα, τη 2^η αιτία αγγειίτιδας στα μικρά παιδιά, στο Δυτικό ημισφαίριο, (~ 9/100.000 παιδιά/έτος), μετά την πορφύρα Henoch-Schönlein (~ 20/100.000 παιδιά/έτος).

Η αιτιοπαθογένεια της νόσου παραμένει άγνωστη, ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις ότι η NK εκδηλώνεται ως ανοσολογική απάντηση σε έναν ή περισσότερους λοιμογόνους παράγοντες (π.χ. *Streptococcus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Propionibacterium acnes*, *Bartonella henselae*, *Coxiella burnetii*, *Mycoplasma*, *Chlamydia pneumoniae*, *Rickettsia*, *Coronavirus*, Αδενοϊοί, Ερπητοϊοί, EBV, ιός ιλαράς, Parvo-ιός B19, Rotavirus) σε άτομα με γενετική προδιάθεση.

Κλινική εικόνα: Η NK χαρακτηρίζεται από **υψηλό πυρετό** (39-40 °C) διάρκειας τουλάχιστον 5 ημερών ανθεκτικό στα αντιπυρετικά, ανορεξία, αδυναμία, κακουχία, αρθραλγίες, μυαλγίες, ευερεθιστότητα, αμφοτερόπλευρη **μη εξιδρωματική επιπεφυκίτιδα**, ερύθημα και **εξέλκωση των χειλέων και του στοματικού βλεννογόνου, εξέρυθρη (μοροειδής) γλώσσα, τραχηλική λεμφαδενοπάθεια**, οίδημα και ερυθρότητα των άκρων και **πολύμορφο εξάνθημα**.

Το δερματικό εξάνθημα της NK είναι συρρέον, κηλιδοβλατιδώδες, σπανίως κνιδωτικό, εμφανίζεται κυρίως στα άκρα (**ερύθημα των παλαμών και πελμάτων, περιονύχια δακτυλική απολέπιση, οίδημα άκρων χειρών και ποδών στην υποξεία φάση**) και στον κορμό, συχνά στην περιοχή των σπαργάνων (**πύελος και περίνεο**), οδηγώντας σε έντονη ερυθρότητα τοπικά και τελικά στη χαρακτηριστική απολέπιση του δέρματος στην προσβληθείσα περιοχή.

Ανευρύσματα των στεφανιαίων αγγείων εμφανίζονται σε ποσοστό 15-25% των παιδιών χωρίς θεραπεία και μπορεί να οδηγήσουν σε έμφραγμα μυοκαρδίου και αιφνίδιο καρδιακό θάνατο. Εκτός των ανευρυσμάτων, κατά την οξεία φάση την νόσου μπορεί να προκληθεί μυοκαρδίτιδα, ανεπάρκειες βαλβίδων και κυρίως της μιτροειδούς, καθώς και περικαρδίτιδα. Στις ανεπτυγμένες χώρες, η νόσος έχει πλέον επισκιάσει τον ρευματικό πυρετό και αποτελεί την κύρια αιτία επίκτητης καρδιοπάθειας στα παιδιά, ειδικά σε χώρες της Άπω Ανατολής.

Σημαντικό πρόβλημα στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου αποτελεί το γεγονός ότι αρκετοί ασθενείς δεν πληρούν όλα τα διαγνωστικά κριτήρια της NK, δηλαδή έχουν λιγότερα των τεσσάρων, εμφανίζοντας έτσι τη λεγόμενη **άτυπη ή ατελή νόσο Kawasaki**. Η συχνότητα της άτυπης NK κυμαίνεται στο 10% του συνόλου των ασθενών που εμφανίζουν τη νόσο.

Εργαστηριακός έλεγχος: Στη NK, ανευρίσκουμε λευκοκυττάρωση, με το 50% των ασθενών να έχουν WBC > 15.000/μl, με πολυμορφοπυρηνικό τύπο και αριστερά στροφή. Η TKE και η CRP ανευρίσκονται υψηλές στο σύνολο των πασχόντων παιδιών κατά την οξεία φάση. Η θρομβοκυττάρωση (PLT > 450.000/μl) αποτελεί εργαστηριακό εύρημα της υποξείας φάσης της NK, έτσι ώστε, ενώ θεωρείται χαρακτηριστικό της νόσου, σπάνια ανευρίσκεται όταν αναζητείται κατά την 1^η εβδομάδα της οξείας νόσησης. Άλλα, λιγότερο συχνά εργαστηριακά ευρήματα είναι: μέτρια αύξηση των τρανσαμινασών (*ιδίως της ALT*), ήπια αναιμία, πυουρία, υπολευκωματιναιμία και υπονατριαιμία. Χαρακτηριστική της νόσου είναι η διαταραχή του μεταβολικού προφίλ, με αύξηση των τριγλυκεριδίων και της LDL και ελάττωση της HDL.

Θεραπευτική παρέμβαση

Η έγκαιρη διάγνωση της νόσου Kawasaki [και η διαφορική διάγνωσή της από οστρακιά, ιλαρά, σύνδρομο τοξικού shock (TSS), σύνδρομο Stevens-Johnson, λεπτοσπείρωση, κ.ά.], είναι ουσιώδης για τη μείωση της πιθανότητας ανάπτυξης ανευρυσμάτων στα στεφανιαία αγγεία, δεδομένου ότι η εφαρμογή της θεραπευτικής αγωγής μετά τη 10^η ημέρα από την έναρξη της νόσου συνδέεται με δυσμενή πρόγνωση κι αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης αγγειακής βλάβης.

Έτσι, η θεραπευτική παρέμβαση, στην οξεία φάση της NK, εστιάζεται στον περιορισμό της φλεγμονής στα στεφανιαία αγγεία, στην αναστολή της ενεργοποίησης των αιμοπεταλίων και στην προφύλαξη από αρτηριακή θρόμβωση. Βασικά βήματα στη θεραπεία της NK, είναι:

1. Η αντιμετώπιση του παιδιατρικού ασθενούς, που προσέρχεται ή διακομίζεται στο ΚΥ ή στο ΤΕΠ, με εικόνα οξέος εμπυρέτου με εξάνθημα, που γεννά την υποψία της διάγνωσης νόσου Kawasaki, τελείται παράλληλα με την κλινική και την εργαστηριακή διερεύνηση.
2. Μεριμνούμε για την επαρκή οξυγόνωση του ασθενούς, χορηγώντας O₂ στα 4-8 lt/min, με απλή παιδιατρική προσωπίδα οξυγόνου ή με ρινική κάνουλα σε ροή 3-5 lt/min.
3. Τοποθετείται 3way φλεβική γραμμή και χορηγούμε αρχικά κρυσταλλοειδή, 500-1000 ml NaCl 0,9% ή R/S ή R/L, για ενυδάτωση του ασθενούς και συντήρηση του ισοζυγίου.
4. Εκτελούμε άμεσα ΗΚΓ και ελέγχουμε τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (ΑΠ, σφύξεις -HR, αναπνευστική συχνότητα -RR, κορεσμός O₂-SpO₂, θερμοκρασία °C), καθώς και τα επίπεδα γλυκόζης με Dextro-stick. Λαμβάνονται αίμα και ούρα, για εργαστηριακό έλεγχο. Έτσι, διενεργούμε γενική αίματος και έναν αδρό βιοχημικό έλεγχο (Glu, Urea, Creat., CRP, TKE, AST/ALT, γ-GT, LDH, K⁺, Na⁺, Ca⁺⁺, CK-MB, cTnI, γενική ούρων, κ.λπ.).
5. **Υπεράνοση γ-σφαιρίνη (Intravenous Immune-Globulin IVIG, Sandoglobulin 3 g/vial):** Χορηγείται εφάπαξ σε υψηλές δόσεις 2 g/kg σε συνεχή (iv) έγχυση, σε χρονικό διάστημα έγχυσης 8-12 ωρών. Η θεραπεία με IVIG θεωρείται πιο αποτελεσματική όταν χορηγείται έγκαιρα και συγκεκριμένα προτιμότερο μεταξύ της 5^{ης} και 7^{ης} ημέρας από την έναρξη του πυρετού. Όταν η θεραπεία χορηγηθεί πριν την 5^η ημέρα της νόσου δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματική και δεν προστατεύει από τις καρδιαγγειακές εκδηλώσεις της NK.
6. **Ασπιρίνη:** Συνιστάται κατά την οξεία φάση – συμπληρωματικά της IVIG – σε δοσολογία αντιφλεγμονώδους δράσης, δηλαδή 80-100 mg/kg ημερησίως, διηρημένη σε τέσσερις δόσεις, μέχρι ο ασθενής να παραμείνει απύρετος για 4-5 ημέρες. Ακολούθως, η δόση της ασπιρίνης ελαττώνεται σε 3-5 mg/kg/ημέρα, δηλαδή σε αντιαιμοπεταλιακή δόση, για 6-8 εβδομάδες ή μέχρι οι τιμές των αιμοπεταλίων και της TKE επιστρέψουν στο φυσιολογικό.
7. Σε παιδιά με αλλεργία στην Ασπιρίνη ή σύγχρονη νόσηση από ανεμοβλογιά ή γρίπη (που έχουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης συνδρόμου Reye) προτιμάται η Κλοπιδογρέλη (Plavix, Grepid) σε δόση 1 mg/kg/ημέρα, μέχρι τη μέγιστη δόση των 75 mg (1 tabl.)/ημέρα.
8. Σε 10-15% των ασθενών ο πυρετός συνεχίζεται μετά τη χορήγηση IVIG και Ασπιρίνης, σημείο ενδεικτικό παραμονής της αγγειίτιδας και του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης ανευρυσμάτων. Σε αυτές τις ανθεκτικές περιπτώσεις, συνιστάται χορήγηση και 2^{ης} δόσης γ-σφαιρίνης IVIG 2 g/kg σε συνεχή (iv) έγχυση, ξανά με διάστημα έγχυσης 8-12 ωρών.
9. Σε περιπτώσεις παιδιών στα οποία ο πυρετός και η οξεία φλεγμονή δεν υποχώρησαν μετά από τη λήψη δύο (2) τουλάχιστον ενδοφλέβιων υψηλών δόσεων IVIG, τότε επιχειρείται η χορήγηση ώσεων Μεθυλπρεδνιζολόνης (Lyo-drol 30 mg/kg ανά ημέρα, για 1-3 ημέρες). Επίσης, στις ανθεκτικές μορφές της NK, χορηγείται infliximab – Remicade 100 mg/vial (μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του TNF) σε εφάπαξ δόση 5 mg/kg ΒΣ (έγχυση 2-3 ωρών).

Για την πρόληψη της θρόμβωσης των στεφανιαίων ανευρυσμάτων και για την αποφυγή εμφράγματος μυοκαρδίου, συνιστάται στα μικρά-μέτρια ανευρύσματα, μέχρι την υποστροφή τους η χορήγηση Ασπιρίνης σε χαμηλή αντιαιμοπεταλιακή δόση 3-5 mg/kg/ημέρα, ενώ σε μεγάλα-γιγαντιαία ανευρύσματα στην Ασπιρίνη προστίθενται από του στόματος αντιπηκτικά (warfarin), ώστε το INR να κυμαίνεται μεταξύ 2,0-3,0 ή LMWH (Clexane: 1 mg/kg, sc).